

Tehnologia Protezelor Parțiale Fixe

Șef Lucrări Dr.

Burde Alexandru

-tehnician dentar-



Disciplina de Propedeutică și
Estetică Dento-Facială

Tehnologia Protezei Parțiale Fixe

- Durata: 14 săptămâni- 2 ore/ săptămână
- Nr. credite: 6 credite
- Locație curs: Amf. Avram Iancu
- Locație l.p.: str. Clinicilor, nr. 32, sala P03, P07
- Prezența curs:
 minim 70% (adică minim 10 prezențe)

Tehnologia Protezei Parțiale Fixe

Formula de calcul a notei finale:

- ◆ **20% – Activitate practică**
 - ✓ Prezență și implicare la stagii
 - ✓ Execuția corectă a lucrărilor practice

- ◆ **10% – Teste pe parcursul semestrului**
 - ✓ **2 teste scrise** (grile, desen, întrebări scurte)
 - ✓ Verifică înțelegerea teoretică a conceptelor esențiale

- ◆ **35% – Examen scris**
 - ✓ Grile + desene + întrebări redacționale
 - ✓ Evaluarea cunoștințelor teoretice aplicate în practică

- ◆ **35% – Examen practic**
 - ✓ **Modelare machetă în timpul examenului** – precizie, detalii, estetică (20%)
 - ✓ **Explicație tehnică & justificarea modului de lucru** (5%)
 - ✓ **Tema de acasă – Punte totală modelată** (10%) – trebuie adusă și evaluată la examen

Teste: **2 teste**

Test 1: **6-12 Aprilie** (săptămâna 7)

Test 2: **25-31 Mai** (săptămâna 13)

Tehnologia Protezei Parțiale Fixe

- Prezența l.p.: **100%** - 14 stagii
 - **NU** există și **NU** se acceptă prerecuperare
 - Orice absență se motivează și recuperează
 - Motivarea se poate face prin adeverință medicală sau plata taxei (30 lei/h x 5 ore pt. un stagiu)
 - **NU** se acceptă **participarea cu alte grupe** la l.p. decât în situații speciale și în limita a 11 locuri/ grupă

Tehnologia Protezei Parțiale Fixe

- Ținuta la l.p.: **halat, păpuci de clinică**
- La curs și l.p este **interzisă** utilizarea:



B) Comportament profesional și colegial adecvat

Sunt interzise următoarele:

- a) Folosirea unui limbaj vulgar/neadecvat/agresiv sau manifestarea de atitudini necorespunzătoare/ jignitoare față de colegi, personalul Universității sau al spitalelor sau față de pacienți etc.
- b) Manifestări lipsite de respect, empatie, compasiune și integritate față de pacienți, exprimate atât prin limbaj verbal cât și nonverbal.
- c) **Utilizarea dispozitivelor electronice în timpul cursurilor și stagiilor, precum folosirea telefonului mobil, a laptopurilor, tabletelor, smartwatch-urilor etc. cu alte scopuri decât cele academice, lectura altor materiale sau utilizarea căștilor.**
- d) Perturbarea liniștii în timpul cursurilor și stagiilor.

Anexa 5 la
Hotărârea
Senatului nr. 8
din 25 iulie 2024
COD DE
CONDUITĂ AL
STUDENȚILOR

Tehnologia Protezei Parțiale Fixe

- Bibliografia-toate se găsesc la Biblioteca UMF
1. **Cursuri**- in format PDF cu parolă- platforma **Prope.ro**
 2. **Proteza Parțială Fixă**- Dorin Borzea, Sorana Baciuc, Diana Ducea. Editura Medicală Universitară. 2002
 3. **Bazele clinice și tehnice ale protezării fixe**- Dorin Bratu, Robert Nussbaum. Editura Medicală.2006
 4. **Tratamentul edentațiilor parțiale prin proteze parțiale fixe**- Alina Monica Picoș, Editura Medicală Universitară. 2015
 5. **Edentația parțială și terapia ei protetică modernă prin restaurări conjuncte**- Ion Coca, Bogdan Oprea, Valentina Coca. Editura Cermaprint.2006

Tehnologia Protezei Parțiale Fixe

- Probleme sau informații suplimentare:



burde.alexandru@umfcluj.com



Alex Burde



Microsoft
Teams

Burde Alexandru



Alex Burde

- Program de consultații la sediul Disciplinei:

Vineri: 13-15

Tehnologia Protezelor Parțiale Fixe

Curs 1

Edentația parțială -considerații generale, clasificări-



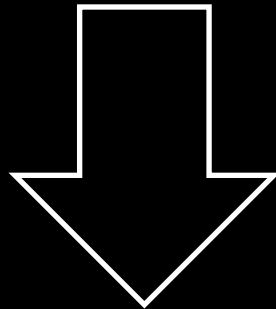
Șef Lucrări Dr.

Burde Alexandru

Edentația parțială

Edentația parțială = *definiție:*

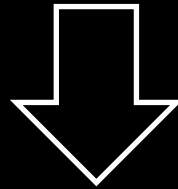
starea patologică a ADM caracterizată prin
absența a 1-15 unități dento-pardodonale de pe
o arcadă.



de la **lipsa unui dinte** până la **prezența unui singur dinte/ arcadă**

Edentația parțială

Pierderea unuia /mai multor dinti



Spații edentate / breșe edentate

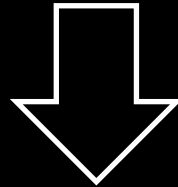
Breșele edentate pot varia prin:

- topografie = localizare
- întindere = mărime
- frecvență = numărul breșelor
- vechime

Edentația parțială

În funcție de breșele edentate

- topografie = localizare
- întindere = mărime
- frecvență = numărul breșelor
- vechime

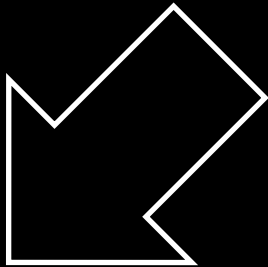


Apar tulburări:

1. Estetice
2. Fonetice
3. Masticatorii
4. Autoîntreținere a ADM

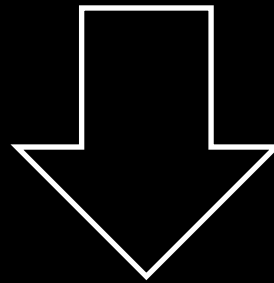
Edentația parțială

Edentația parțială-forme clinice



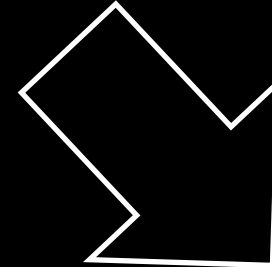
Dobândită

- apare **după erupția** parțială/completă a dintelui
- cea mai frecventă formă



Inaparentă

- formă a ed. part. dobândită
- când **breșa edent.** este **închisă** complet prin migrarea dinților învecinați



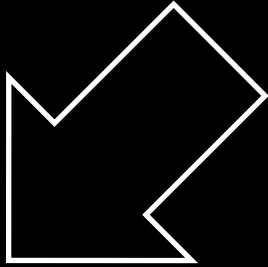
Aparentă

- Apare înainte de erupția pe arcadă
- Retenția intramaxilară a unor dinți definitiv
- Hipodonția:
 - Redusă (unident.)
 - Întinsă (grup dentar)
 - Anodonția (absență totală)

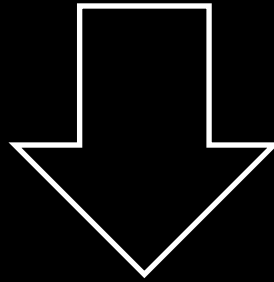
Diagnostic diferențial: Anamneză + ex. radiologic

Edentația parțială

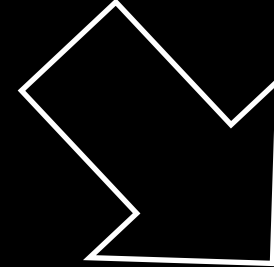
Edentația parțială-forme clinice



Dobândită



Inaparentă

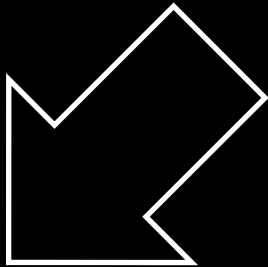


Apărentă



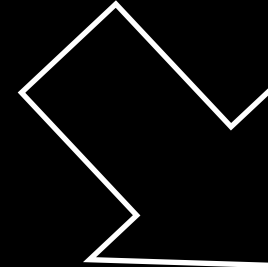
Edentația parțială

Edentația parțială-forme clinice



Adevărată

- apare după pierderea dinților și apariția breșei
- cea mai frecventă formă



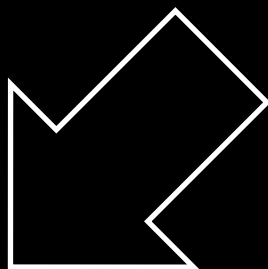
Pseudoedentație

- Nu apare breșă
- când breșa edent. este închisă complet prin migrarea dinților învecinați
- Ex.: extragere precoce M1 și M2 migrează

Diagnostic diferențial: Anamneză + ex. radiologic

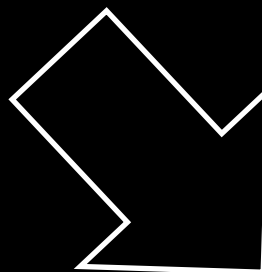
Etio patogenia edentația parțială

În funcție de **factorul care cauzează** edent. parț.:



Cauze **dobândite**

1. Caria și complicațiile
2. Afecțiuni parodontale
3. Extracții
4. Traumatisme
5. Iatrogenii
6. Cauze chirurgicale/ oncologice



Cauze **ereditare**

1. Hipodonția
2. Anodonția
3. Sindrom Down
4. Displazia ectodermala
5. Despicăturile labio-maxilo-palatine

Etio patogenia edentația parțială

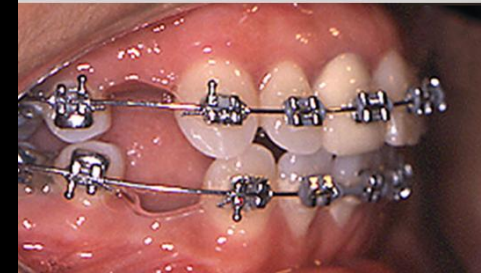
Cauze **dobândite**



1. Caria și complicațiile



2. Afecțiuni parodontale



3. Extracții în scop ortodontic



4. Traumatisme



5. Iatrogenii



6. Cauze chirurgicale/ oncologice

Etio patogenia edentația parțială

Cauze ereditare



1. Hipodontia



2. Anodonția



3. Sindromul Down



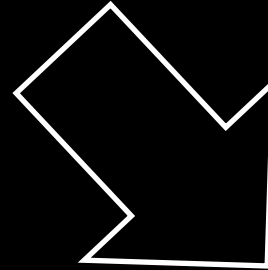
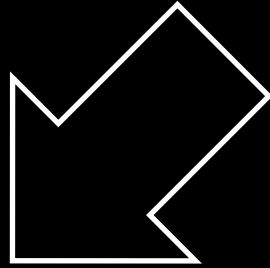
4. Displazia ectodermala



5. Despicăturile labio-maxilo-palatine

Simptomatologia edentației parțiale

În funcție de **intensitate**:



- Simptomatologie **atenuată**

- În breșe reduse
- Breșe în zona laterală
- Fără tulburări funcționale grave

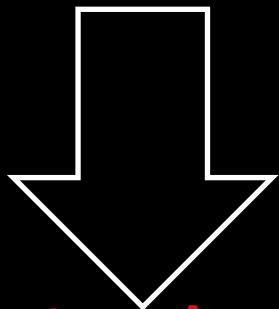
- Simptomatologie **accentuată**

- Constituie urgențe protetice
- Breșe extinse
- Breșe în zona frontală
- Împiedică desfășurarea activităților socio-profesionale



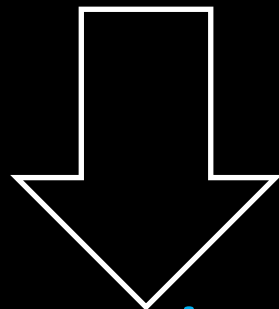
Complicațiile edentației parțiale

În funcție de **tulburările** generate:



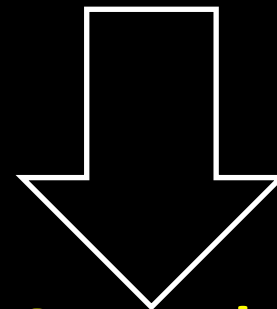
Locale

1. Migrările dentare
2. Manifestări parodontale
3. Manifestări la nivelul creștelor edentate
4. Manifestări ocluzale



Loco-regionale

1. Modificări musculare
2. Disfuncții ATM
3. Scăderea DVO



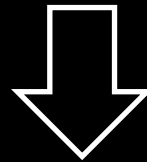
Generale

1. Complicații digestive
2. Complicații psihice
3. Scăderea DVO
4. Instalare parafuncții

Complicațiile **LOCALE** ale edentației parțiale

1. Migrările dentare

- Sunt modificări de poziție a dinților restanți
- Apar datorită lipsei antagoniștilor sau a vecinilor, în absența tratamentului



Absența unui dinte **întrerupe transmiterea orizontală** a solicitărilor ocluzale

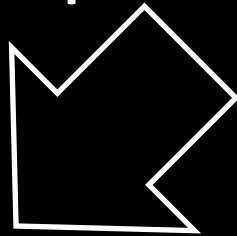
Consecințe:

Denivelează planul de ocluzie, elimină dinții din alveole, expune furcația la dinții pluradiculari

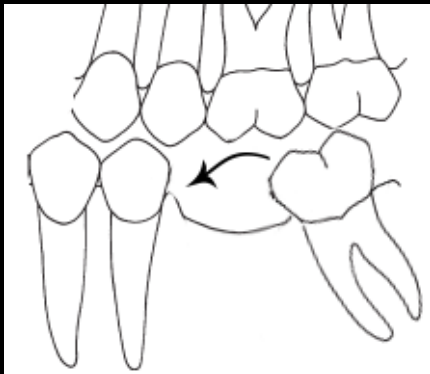
Complicațiile **LOCALE** ale edentației parțiale

1. Migrările dentare

Tipuri de migrări dentare

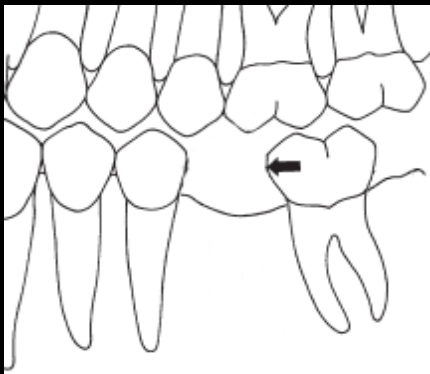


Orizontale



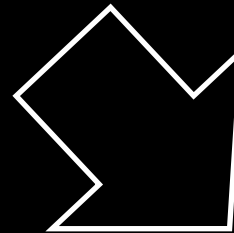
Basculare

Migrare orizontală
prin inclinare ax
longitudinal
spre edentație

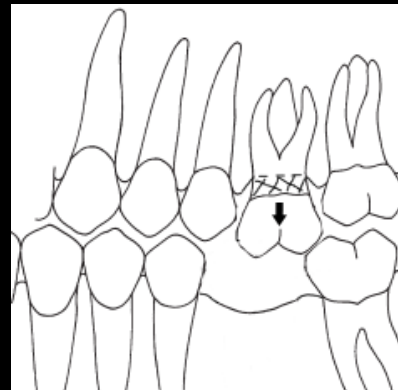


Translația

Migrare orizontală
prin deplasare
corporală, cu
menținerea axului
longitudinal corect



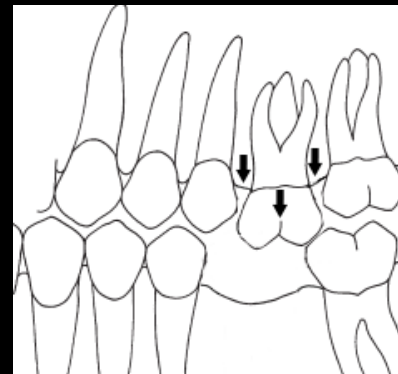
Verticale



Extruzia

Migrare verticală
Cu ieșirea dintelui din alveolă.

Modifică raport
coroana clinică/ radacina clinică



Egresiunea

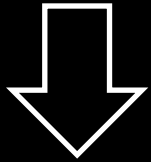
Migrare verticală împreună cu
procesul alveolar

Menține raport
coroana clinică/ rădăcină clinică

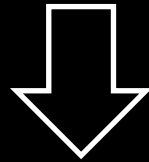
Complicațiile **LOCALE** ale edentației parțiale

2. Manifestări parodontale

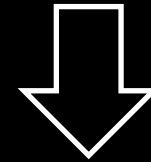
- Se realizează prin mecanisme multiple



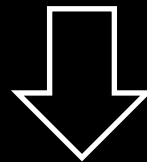
Impact alimentar direct
asupra parodonțiului
dinților restanți



Fenomene involutive a
papilelor interdentare



Fenomene inflamatorii
prin acumulare plăcii
bacteriene, când dinții
restanți se înclină

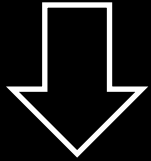


Solicitare paraxială
a dinților basculați

!!! Mai nocivă de 60 ori
decât solicitare axială

Complicațiile **LOCALE** ale edentației parțiale

3. Manifestări la nivelul creștelor edentate



Reducerea progresivă
a volumului osos disponibil
la nivelul creștei edentate

=ATROFIA



ATROFIA poate fi:

- Lentă sau rapidă
- Redusă sau masivă

ATROFIA depinde de:

- vârsta pacientului (atrofia accentuată la vârstnici)
- vechimea edentației
- cauza edentației
- afecțiunile generale (endocrinopatii, diabet, etc)
- modul în care s-au realizat extracțiile.

Complicațiile **LOCALE** ale edentației parțiale

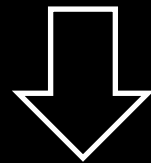
4. Manifestări ocluzale

- Apar și la pierderea unui singur dinte
- Apar cel mai adesea datorită migrărilor dentare

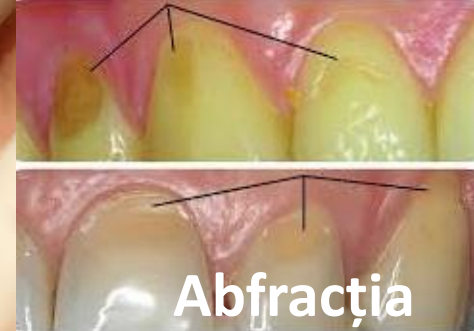


Compensare printr-un mecanism de autoprotecție
ce generează **ocolirea dirijată a contactelor traumatogene** în masticatie

- Poate genera **uzura dentară patologică**



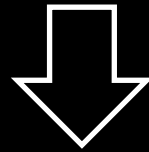
Mecanisme multiple: **abrazie**, **atriție**, **eroziune**, **abfracție**



Complicațiile **LOCOREGIONALE** ale edentației parțiale

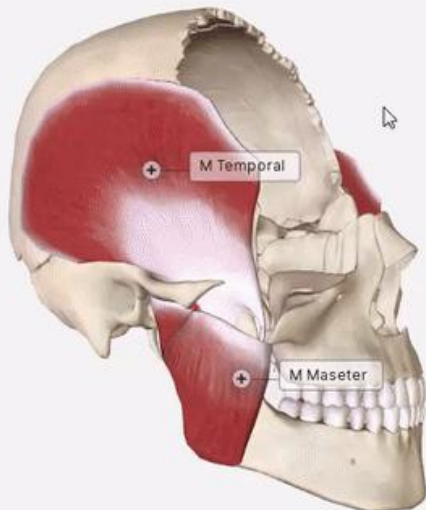
1. Modificări musculare

- Apar când există dizarmonii ocluzale



Determină contracție inegală și/sau asimetrică a:

Mușchilor ridicători ai mandibulei



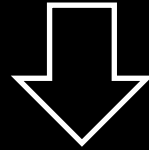
Mușchilor propulsori ai mandibulei



Complicațiile **LOCOREGIONALE** ale edentației parțiale

2. Disfuncții ATM

- Pot fi produse de **modificări ocluzale** , **cauze articulare** sau **modificări DVO**



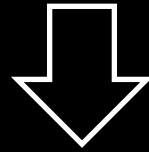
Determină diverse manifestări ale ATM:

1. Cracmente
2. Limitări ale deschiderii gurii
3. Devieri ale traiectoriei de deschidere /închidere/ propulsie
4. Dureri articulare
5. Dureri musculare
6. Spasme musculare
7. Instalare parafuncții

Complicațiile **LOCOREGIONALE** ale edentației parțiale

3. Scăderea DVO

- Cauzat de **pierderea stopurilor ocluzale** de la nivelul dinților cuspidai



Determină diverse manifestări:

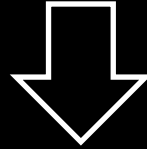
1. Aspect îmbătrânit al feței
2. Migrarea V a dinților frontali
3. Pierderea contactelor stabile ale marginilor incizale a I inf
4. Favorizează uzura dentară patologică



Complicațiile **GENERALE** ale edentației parțiale

1. Tulburări digestive

Poate genera apariția sau agravarea unor boli digestive



Datorită **masticăției ineficiente** (sfârmarea, triturarea și insalivarea bolului alimentar)

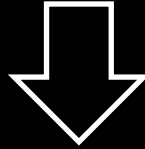


1. Gastrite cronice
2. Enterocolite
3. Ulcer gastric
4. Hipotonii gastrice

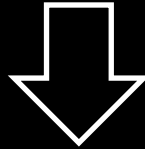
Complicațiile **GENERALE** ale edentației parțiale

2. Tulburări psihice

Survin mai ales în edentațiile din zona frontală



Se manifestă prin **depresie**, **izolare**, **nervozitate**, **lipsa de implicare în activități sociale**



Edentația parțială cauzează:

- Scăderea stimei de sine
- Îmbătrânirea prematură
- Modificarea compartamentului în societate



Clasificarea edentațiilor parțiale

Spațiile edentate pot varia în funcție de **topografie**, **întindere** și **frecvență**

Acestea pot fi:

- Maxilar /mandibular
- Pe o hemiarcadă / întreaga arcada
- În zona frontală / zona laterală
- În **funcție de întindere**:
 - **Redusă** (1-2 dinți absenți)
 - **Întinsă** (3-4 dinți absenți)
 - **Extinsă** (4-9 dinți absenți, implică zona frontal și lat.)
 - **Subtotală** (10-15 dinți absenți)

65535 combinații de dinți restanți și breșe edentate

Clasificarea edentațiilor parțiale

Există mai multe clasificări în funcție de diverse criterii (23 clasificări)

Cele mai populare și utilizate clasificări sunt:

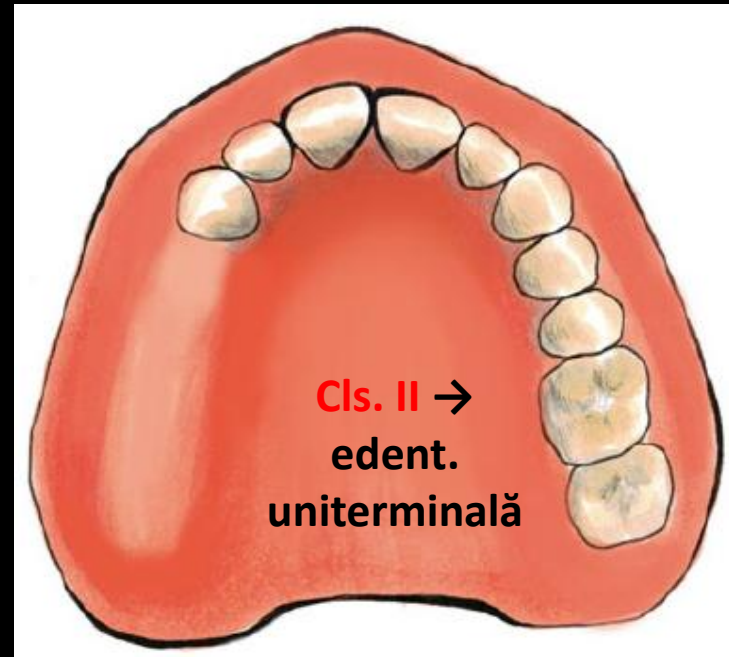
- **KENNEDY** – criteriul topografic și numărul spațiilor edentate
- **COSTA**- criteriul topografic
- **CUMMER**- criteriul terapeutic
- **FRIEDMAN**- criteriul funcțional

Clasificarea edentațiilor parțiale

KENNEDY – criteriul topografic și numărul spațiilor edentate

Clasa **I** → edentatia **biterminala**: cuprinde toate edentațiile din ambele regiuni laterale ale arcadei

Clasa **II** → edentatia **uniterminala**: lipsesc dintr-o regiune laterala;

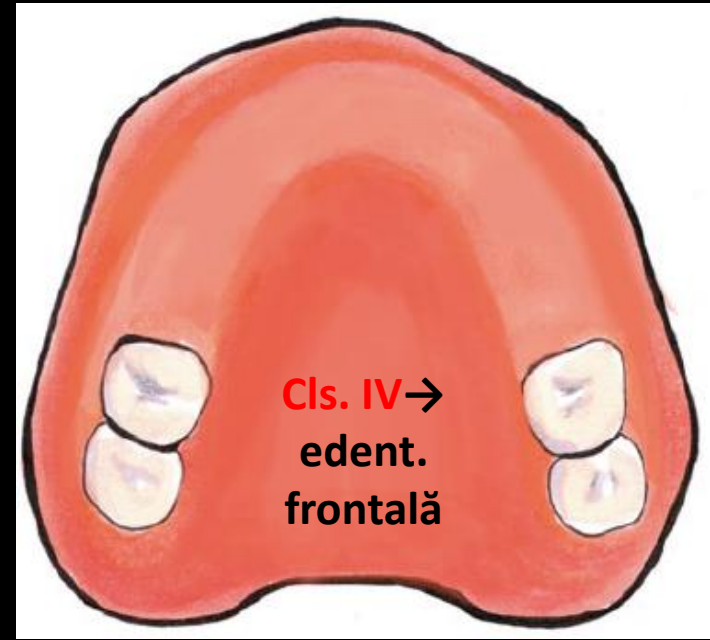
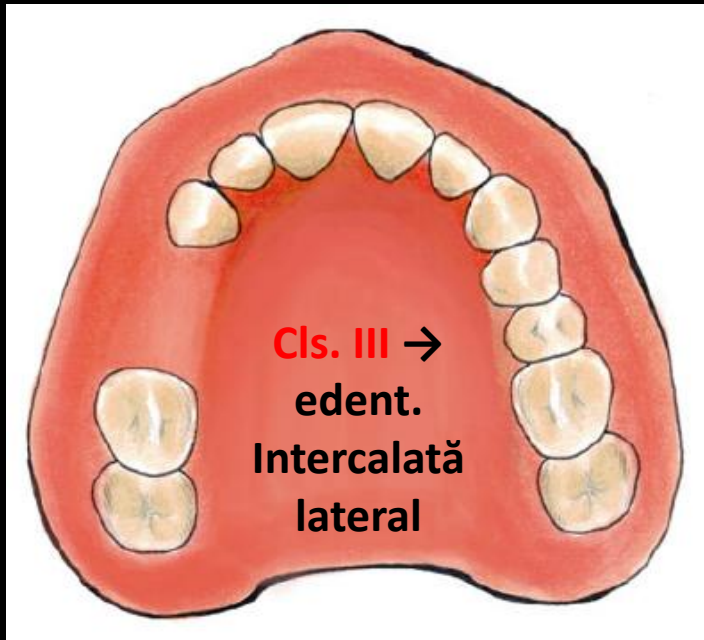


Clasificarea edentațiilor parțiale

KENNEDY – criteriul topografic și numărul spațiilor edentate

Clasa **III** → edentatia laterala (**intercalată**);

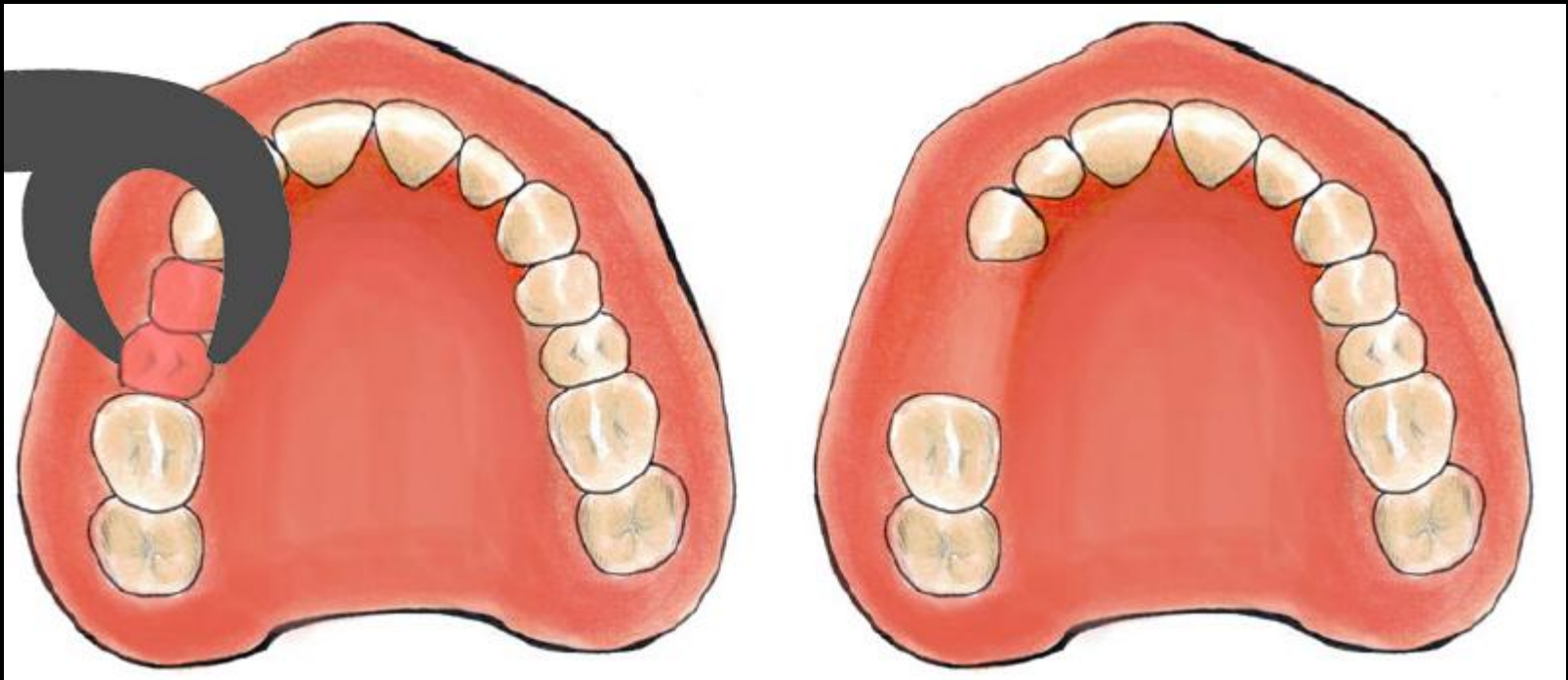
Clasa **IV** → edentatia **frontală**: lipsesc dinți de o parte și de alta a liniei mediene.



Clasificarea edentațiilor parțiale

KENNEDY-reguli de citire a edentației

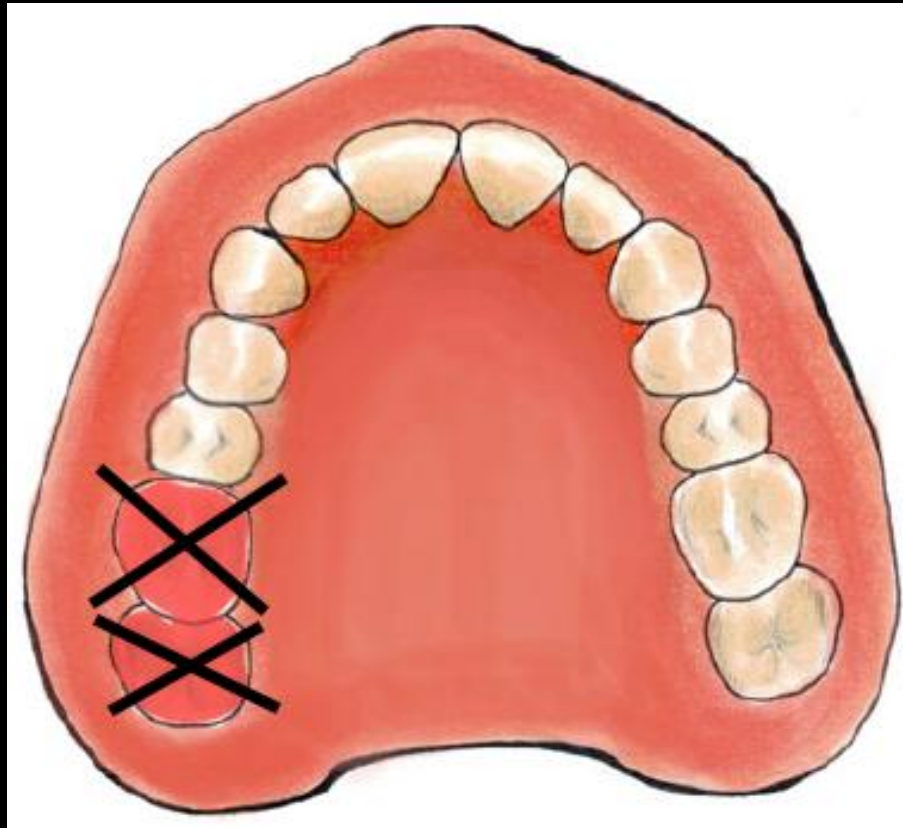
1. Includerea stării de edentație într-o clasă sau alta urmează se face **după o extracție**, nu precede o extracție.



Clasificarea edentațiilor parțiale

KENNEDY-reguli de citire a edentației

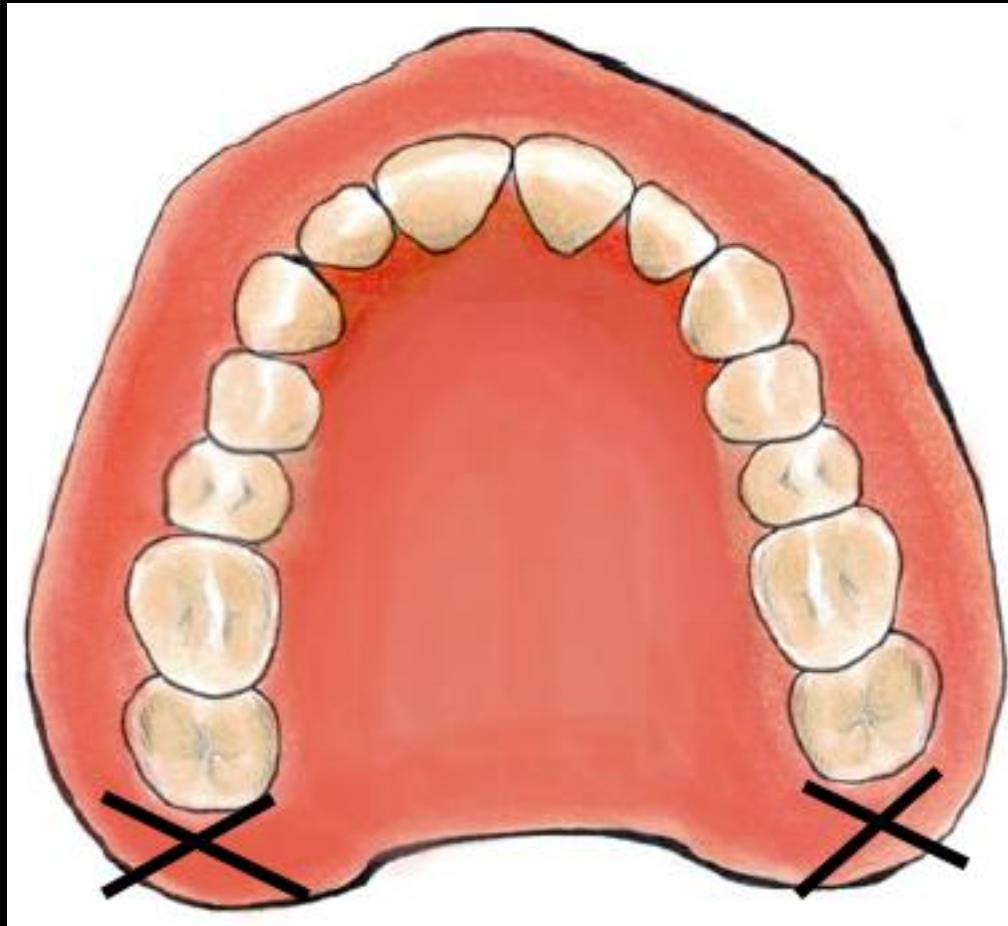
2. Breșele edentate care nu vor fi restaurate prin PPF , **NU** se iau în considerare atunci când se face clasificarea edentației.



Clasificarea edentațiilor parțiale

KENNEDY-reguli de citire a edentației

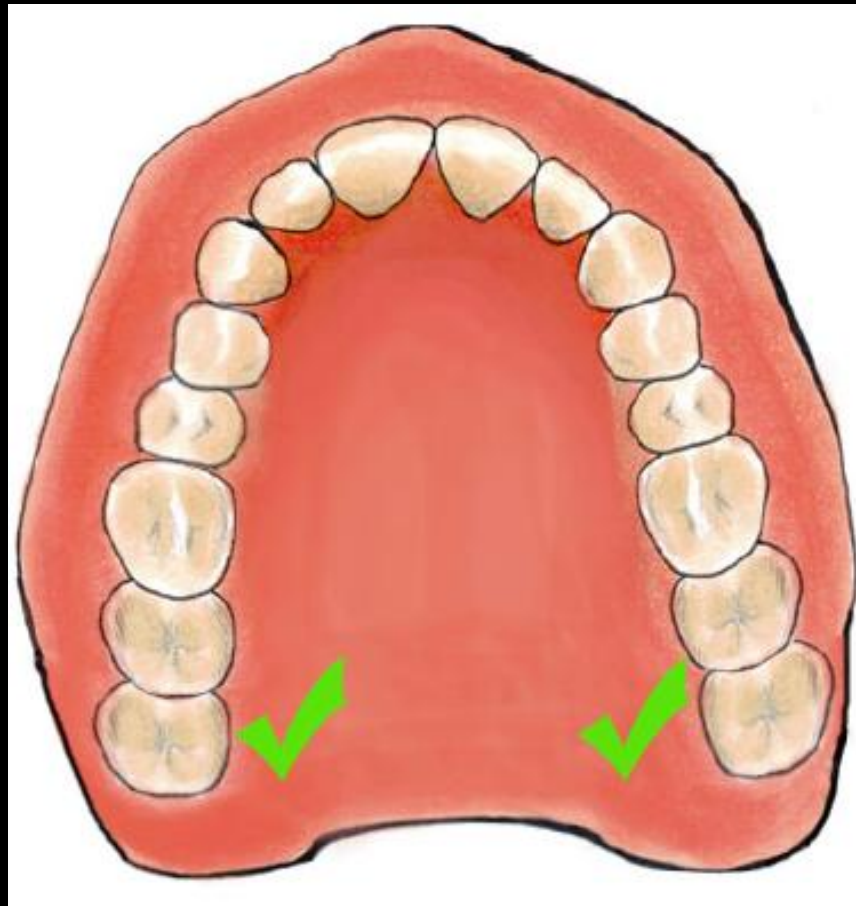
3. Dacă **M3** lipsește, **NU** va fi luat în considerare în clasificare.



Clasificarea edentațiilor parțiale

KENNEDY-reguli de citire a edentației

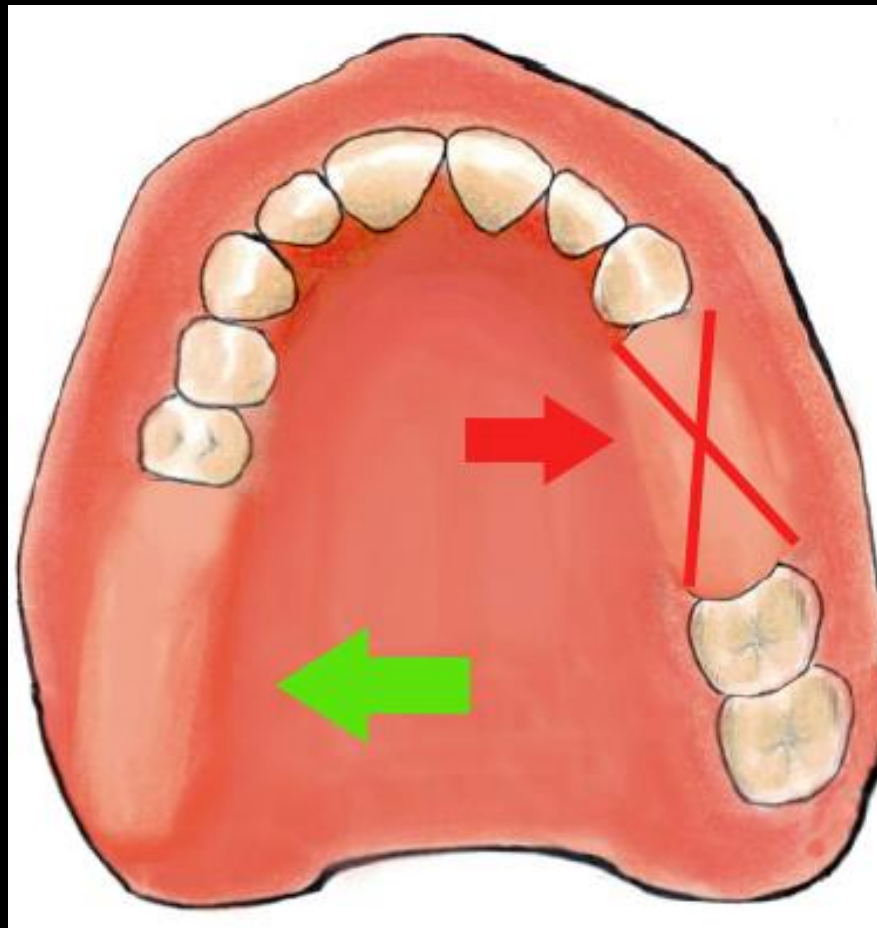
4. Dacă **M3** este prezent și va fi **utilizat** ca dinte stâlp **va fi luat în considerare** în clasificare.



Clasificarea edentațiilor parțiale

KENNEDY-reguli de citire a edentației

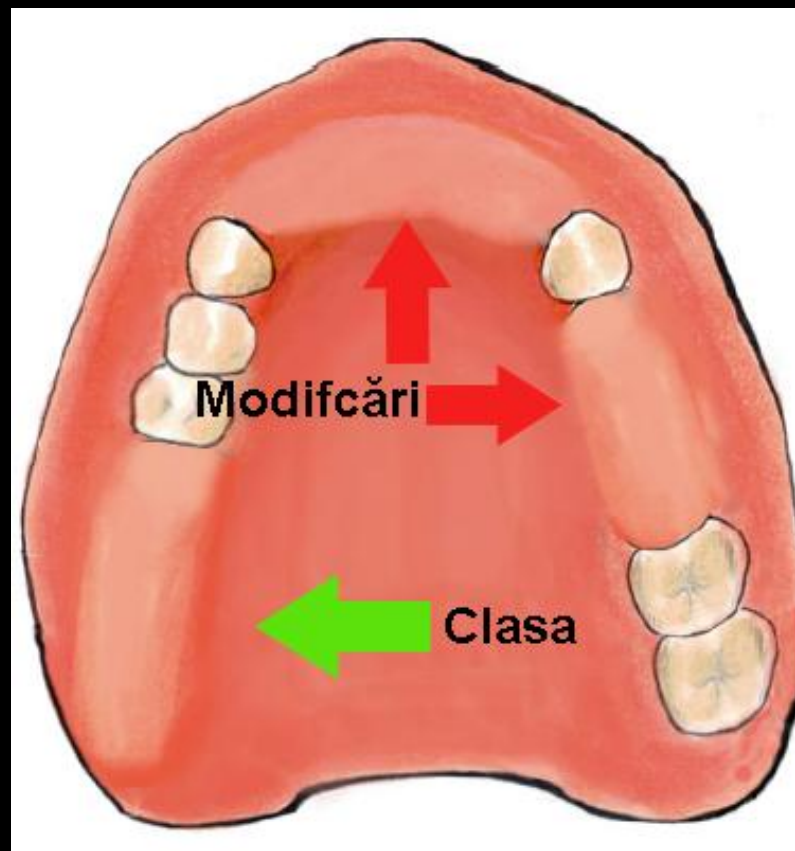
5. Pentru **stabilirea clasei** de edentație se ia în considerare **breșa** situată **cel mai posterior**.



Clasificarea edentațiilor parțiale

KENNEDY-reguli de citire a edentației

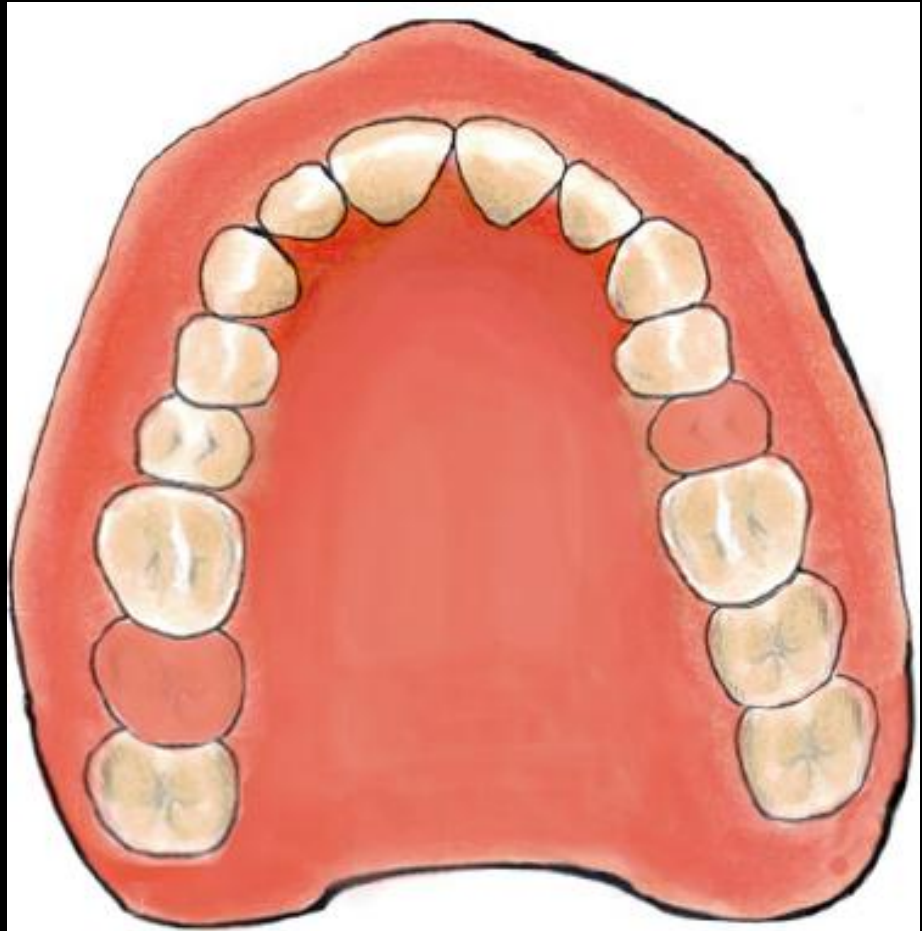
6. Breșele edentate suplimentare față de cele care determină clasa de edentație sunt denumite **modificări**
7. **Modificările** se notează cu **cifre arabe** (Ex: Cls. a II-a, cu 2 modif.)



Clasificarea edentațiilor parțiale

KENNEDY-reguli de citire a edentației

8. **Întinderea breșei** edentate (nr. dinților absenți din breșă) **NU** influențează clasificarea.



Clasificarea edentațiilor parțiale

KENNEDY-reguli de citire a edentației

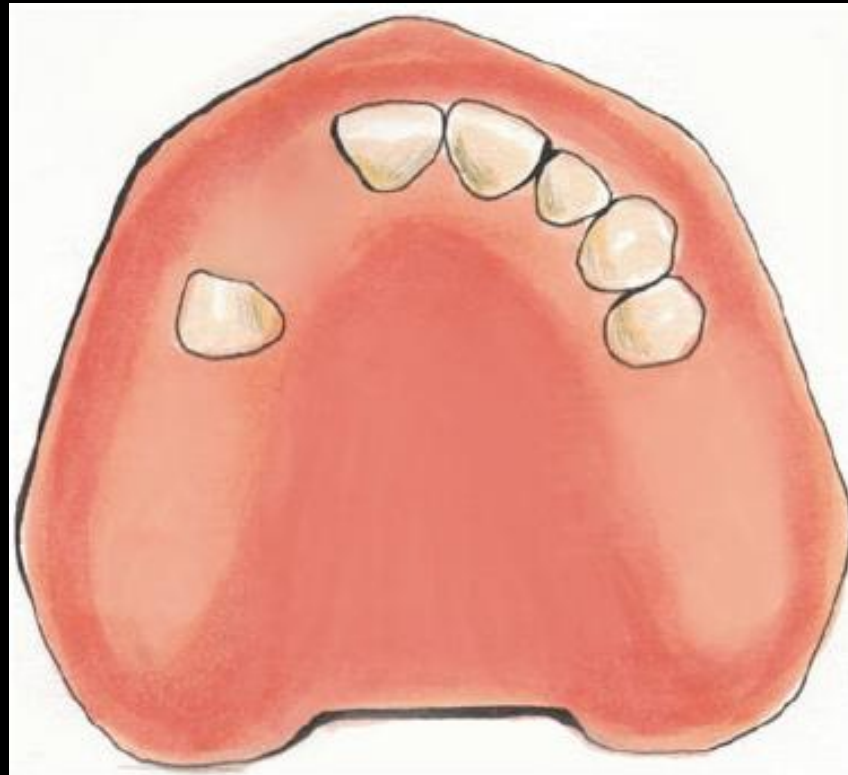
9. Clasa a IV-a **NU** poate prezenta modificări.



Clasificarea edentațiilor parțiale

KENNEDY - Exerciții

X X X X 4 X X 1 | 1 2 3 4 X X X X



Kennedy: Cls. I, cu 1 modificare

Clasificarea edentațiilor parțiale

KENNEDY- Exerciții

X X X X X 3 2 1 | 1 X 3 X X 6 7 X

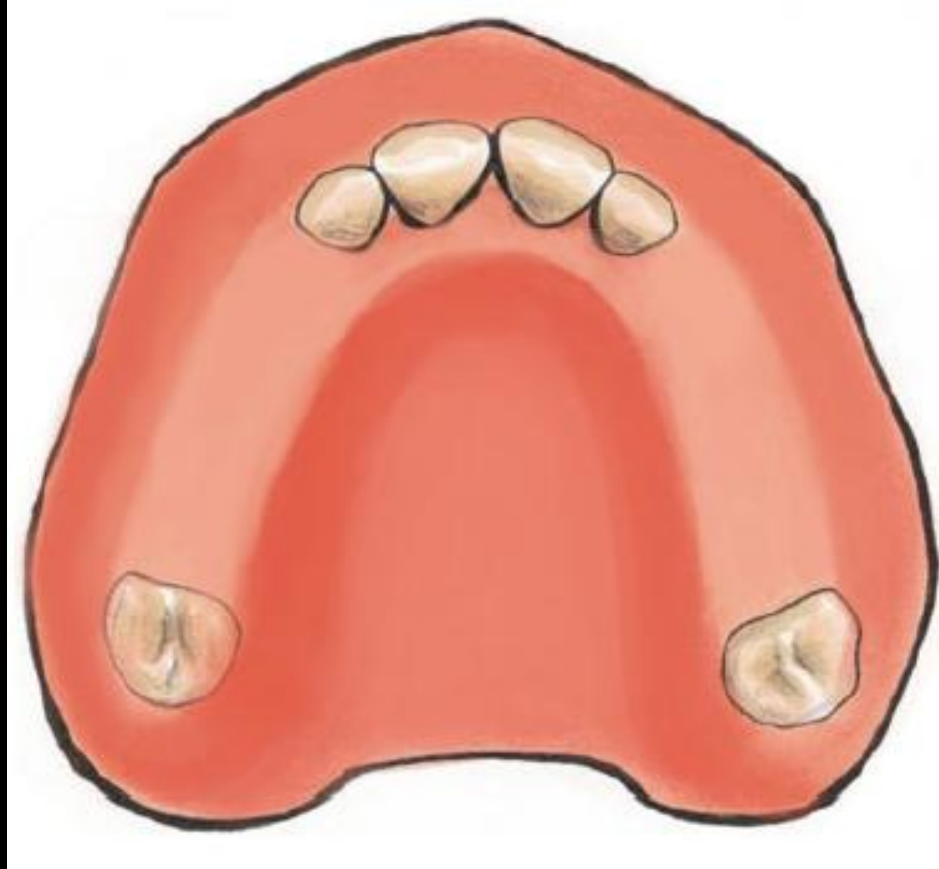


Kennedy: Cls. II, cu 2 modificari

Clasificarea edentațiilor parțiale

KENNEDY- Exerciții

8 X X X X X 2 1 | 1 2 X X X X X 8

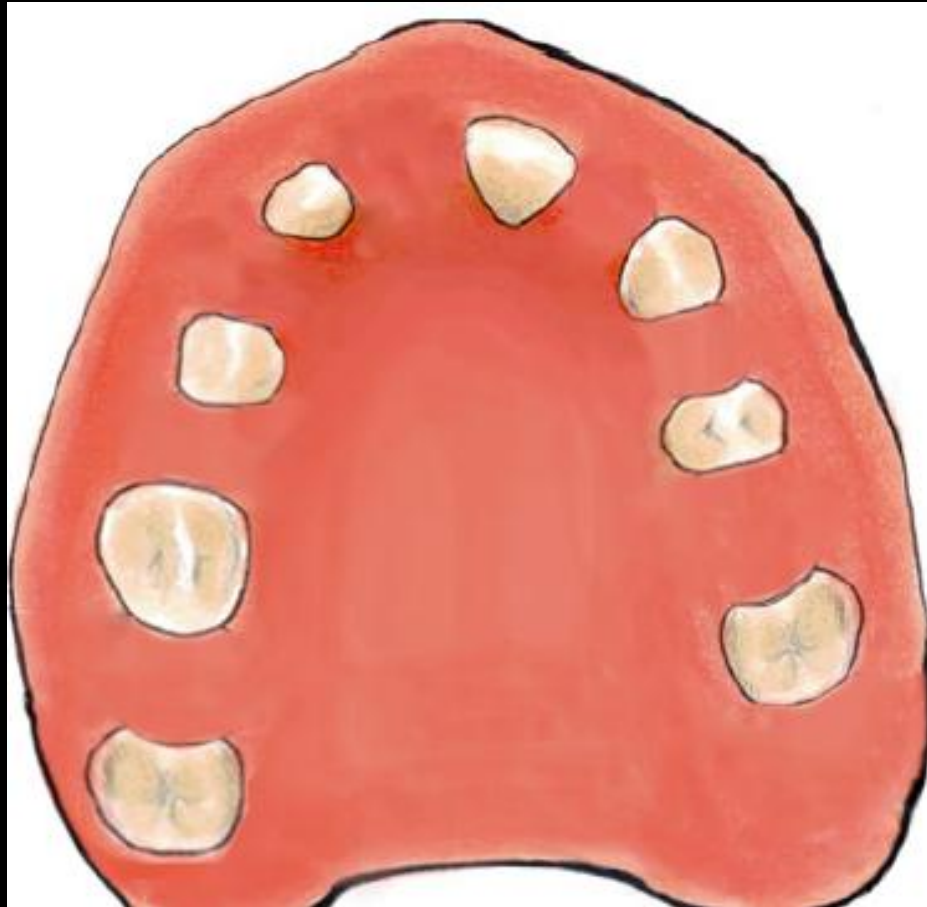


Kennedy: Cls. III, cu 1 modificare

Clasificarea edentațiilor parțiale

KENNEDY - Exerciții

8 X 6 X 4 X 2 X | 1 X 3 X 5 X 7 X

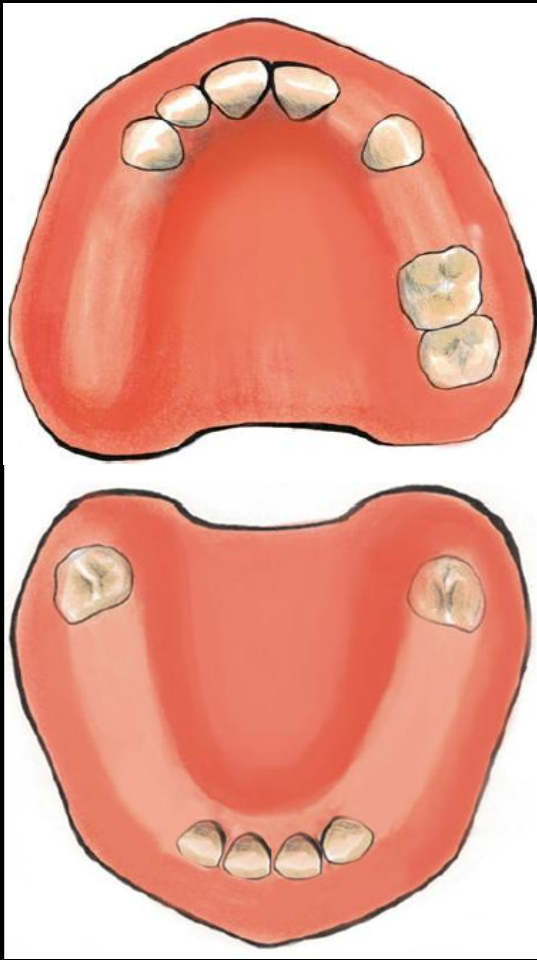


Kennedy: Cls. III, cu 6 modificari

Clasificarea edentațiilor parțiale

KENNEDY-reguli de citire a edentației

10. Dacă analizăm ambele arcade, trebuie denumită arcadă pe care o clasificăm (maxilar/mandibular)



X	X	X	X	X	3	2	1		1	X	3	X	X	6	7	X
8	X	X	X	X	X	2	1		1	2	X	X	X	X	X	8

Kennedy:

Maxilar: cls. a II-a, cu 2 modificări

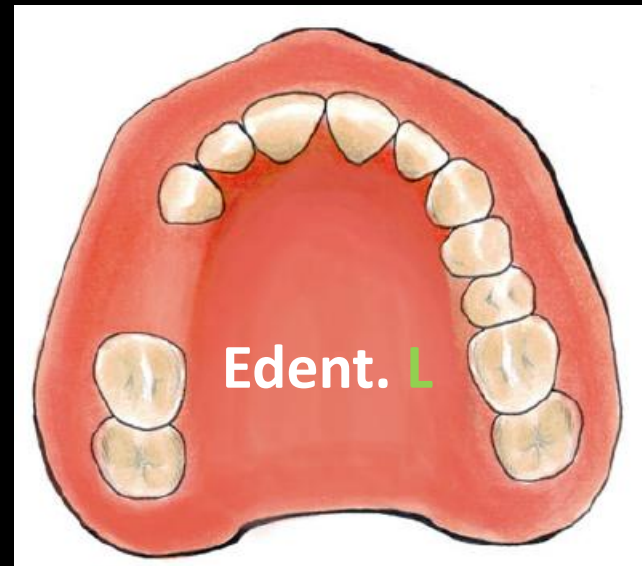
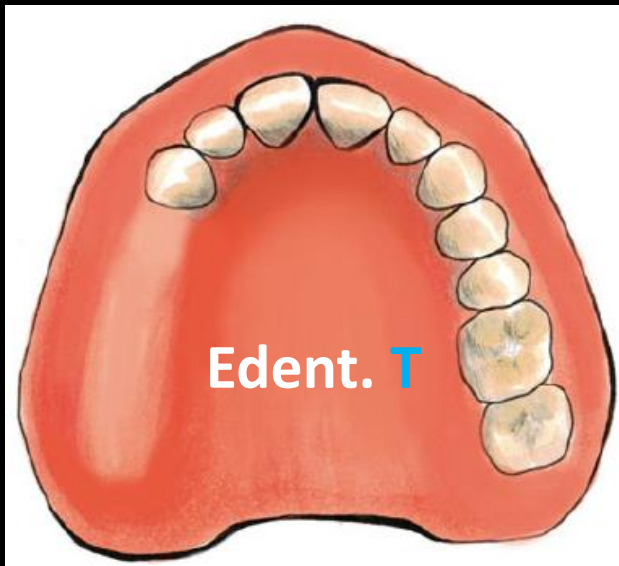
Mandibular: cls. a III-a, cu 1 modificare

Clasificarea edentațiilor parțiale

COSTA – criteriul topografic și utilizează simboluri topografice

Edent. **TERMINALĂ** → (lipsește dinții din zona PM sau/si M), iar breșă este marginită doar mezial de dinți- se notează cu **T**

Edent. **LATERALĂ** → (lipsește dinții din zona PM sau/si M); iar breșă este marginită mezial și distal de dinți- se notează cu **L**

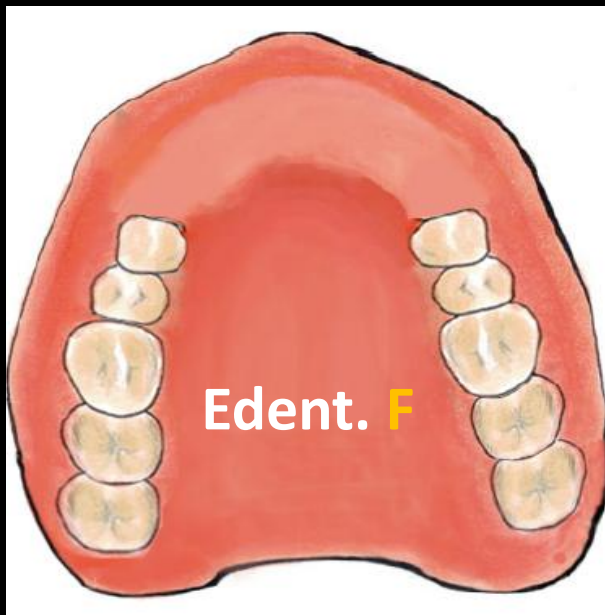


Clasificarea edentațiilor parțiale

COSTA – criteriul topografic și utilizează simboluri topografice

Edent. **FRONTALĂ** → (lipsește dinții **incisivi** sau/si **caninii**), iar **breșa** este **marginită mezial și distal** de dinți- se notează cu **F**

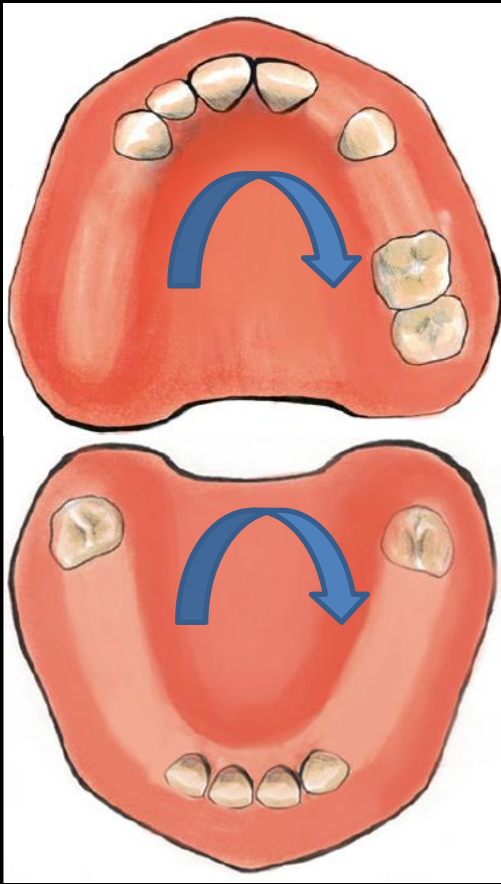
Edent. **MIXTĂ** → edentații la care pot coexista brese frontale, laterale, terminale



Clasificarea edentațiilor parțiale

COSTA-reguli de citire a edentației

1. Citirea edentației se face de la **dr→stg** și la maxilar și la mandibula
2. Bresele de pe ambele hemiarcade se despart printr-o **linie** în scris sau prin **litera M** când citim (M de la median);



Costa:

Maxilar: edent. T | F L

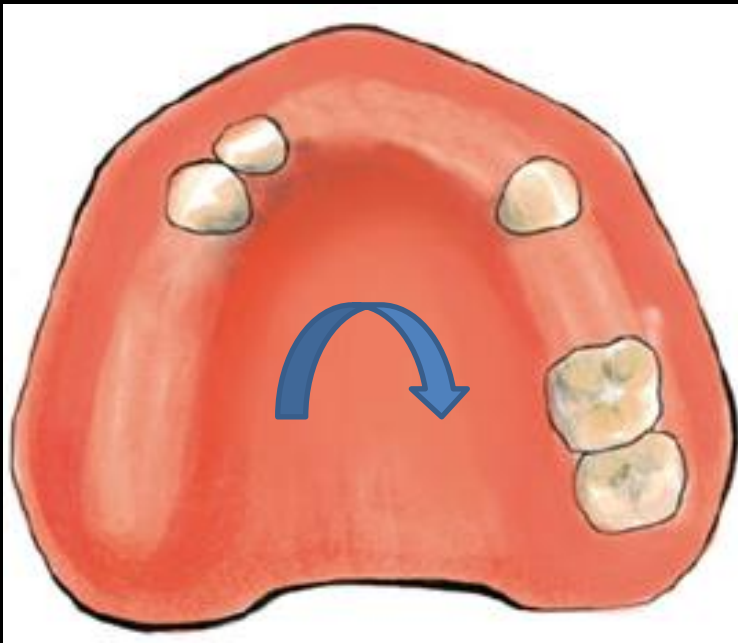
Mandibular: edent L | L

Clasificarea edentațiilor parțiale

COSTA-reguli de citire a edentației

3. Bresele de pe aceeași hemiarcadă se despart prin **virgula**

4. O singură bresă frontală chiar dacă depășește linia mediană primește o singură denumire



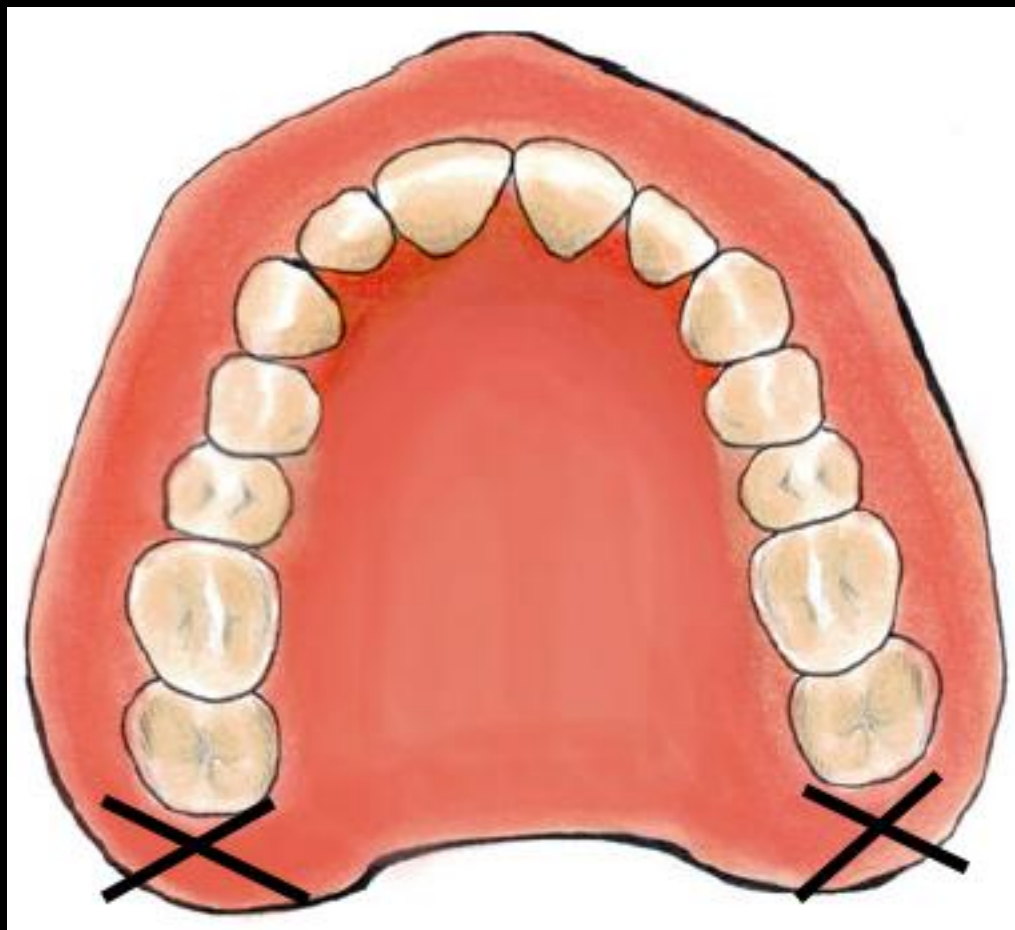
Costa:

Maxilar: edent. T - F - L

Clasificarea edentațiilor parțiale

COSTA-reguli de citire a edentației

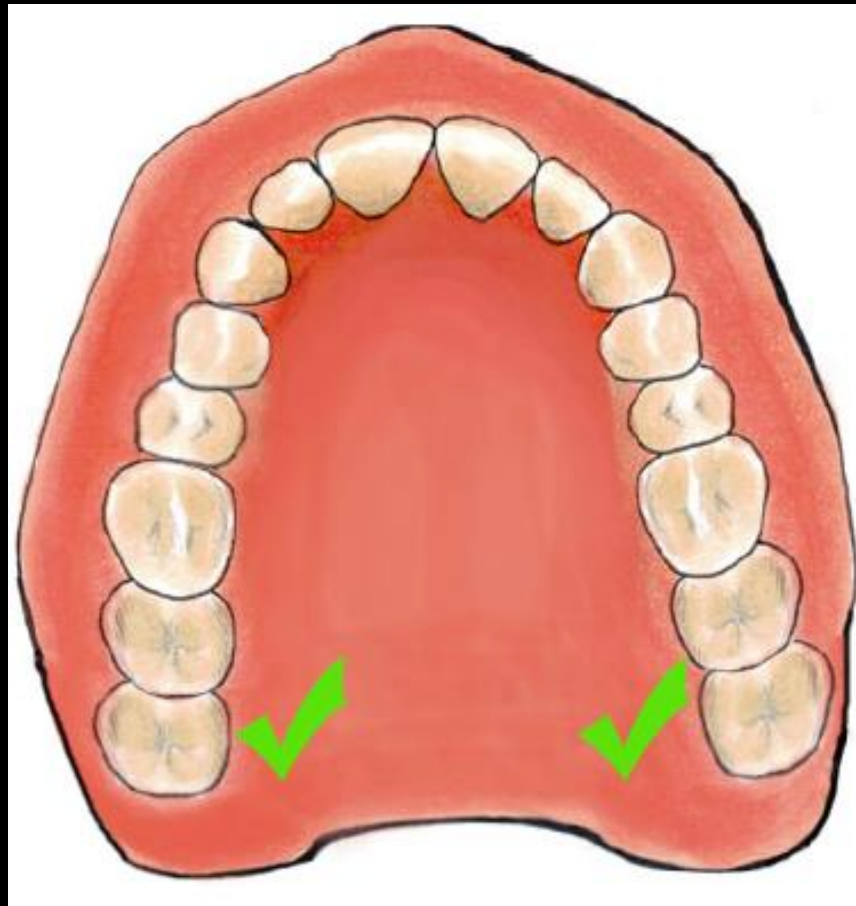
5. Dacă **M3** lipsește, **NU** va fi luat în considerare în clasificare.



Clasificarea edentațiilor parțiale

COSTA-reguli de citire a edentației

6. Dacă **M3** este prezent și va fi **utilizat** ca dinte stâlp **va fi luat în considerare** în clasificare.



Clasificarea edentațiilor parțiale

COSTA-reguli de citire a edentației

7. Dacă există un singur spațiu edentat se va specifica **hemiarcada** dreapta/ stânga



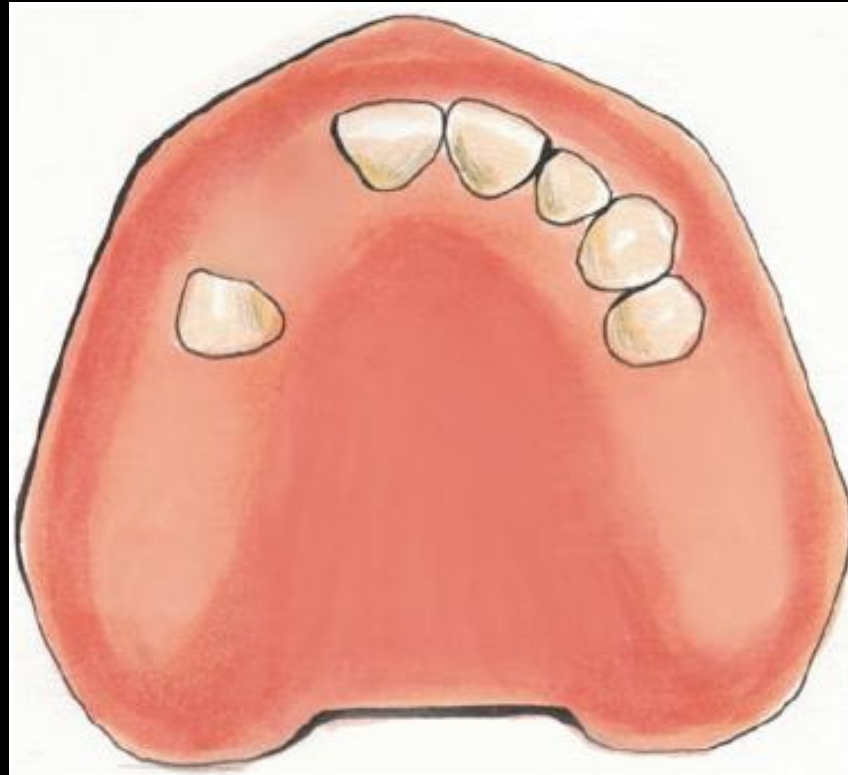
Costa:

Maxilar: edent. L dreapta

Clasificarea edentațiilor parțiale

COSTA- Exerciții

X X X X 4 X X 1 | 1 2 3 4 X X X X



Costa: T, F / T maxilară

Clasificarea edentațiilor parțiale

COSTA- Exerciții

X X X X X 3 2 1 | 1 X 3 X X 6 7 X

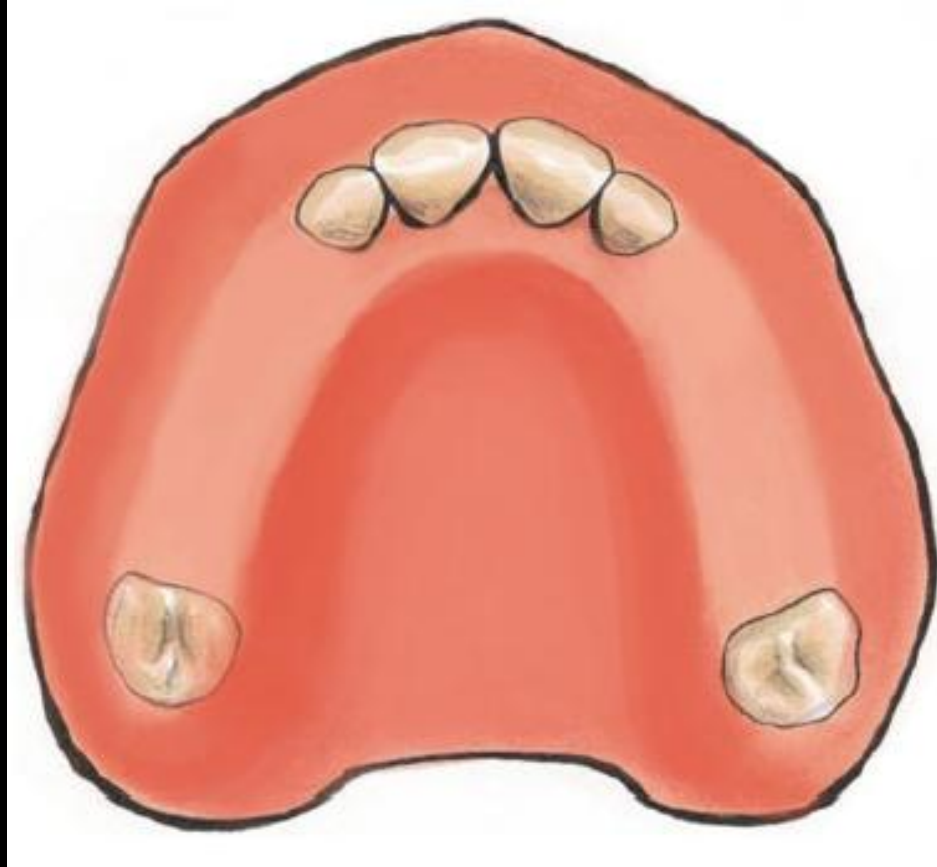


Costa: T /F, L maxilară

Clasificarea edentațiilor parțiale

COSTA- Exerciții

8 X X X X X 2 1 | 1 2 X X X X X 8

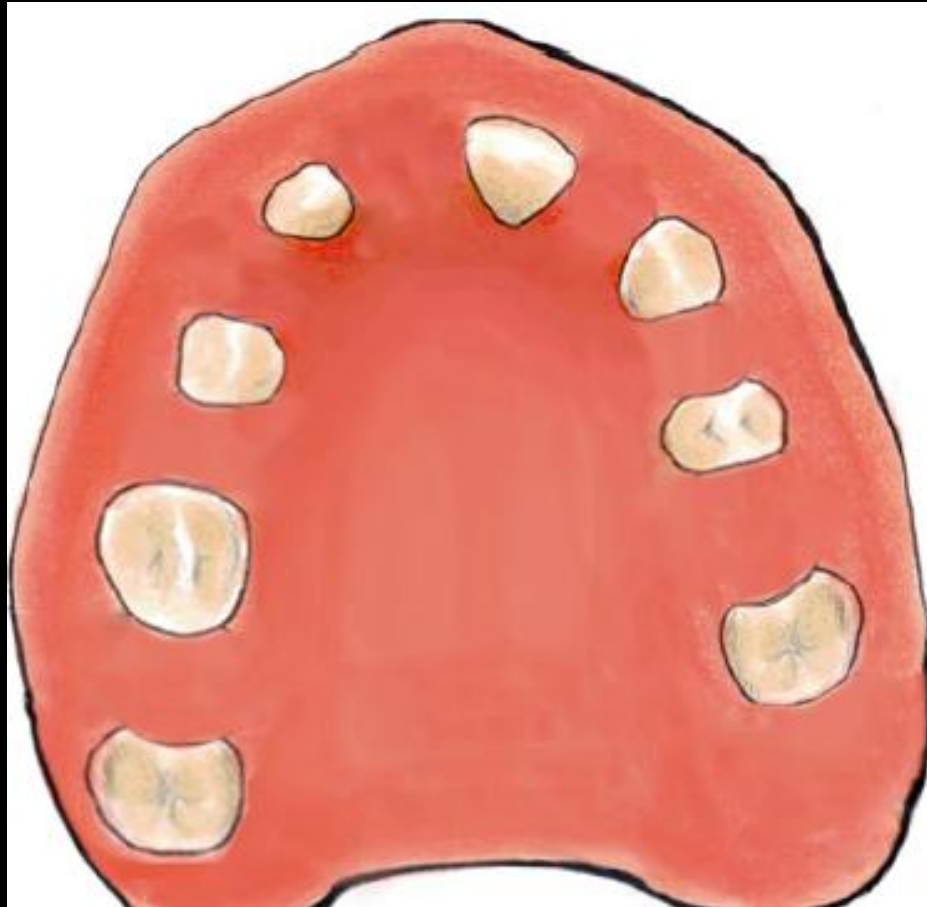


Costa: L, F / F, L maxilară

Clasificarea edentațiilor parțiale

COSTA- Exerciții

8 X 6 X 4 X 2 X | 1 X 3 X 5 X 7 X



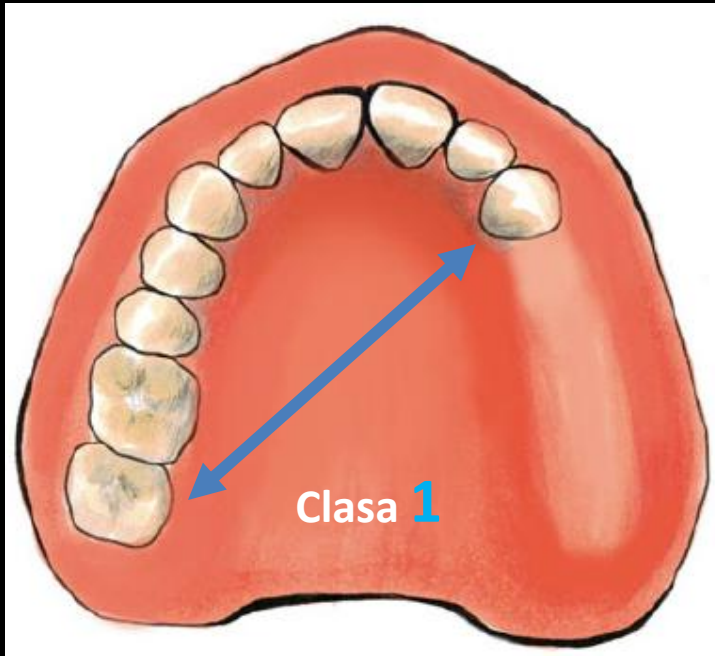
Costa: L, L, F, F / F, L, L maxilară

Clasificarea edentațiilor parțiale

CUMMER – criteriul terapeutic dat de **linia ce uneste dintii stalpi**

Clasa **1** → linia ce uneste dintii stalpi e **oblica in diagonala** fata de linia medio-sagitala

Clasa **2** → linia ce uneste dintii stalpi e **transversala** fata de linia medio-sagitala;

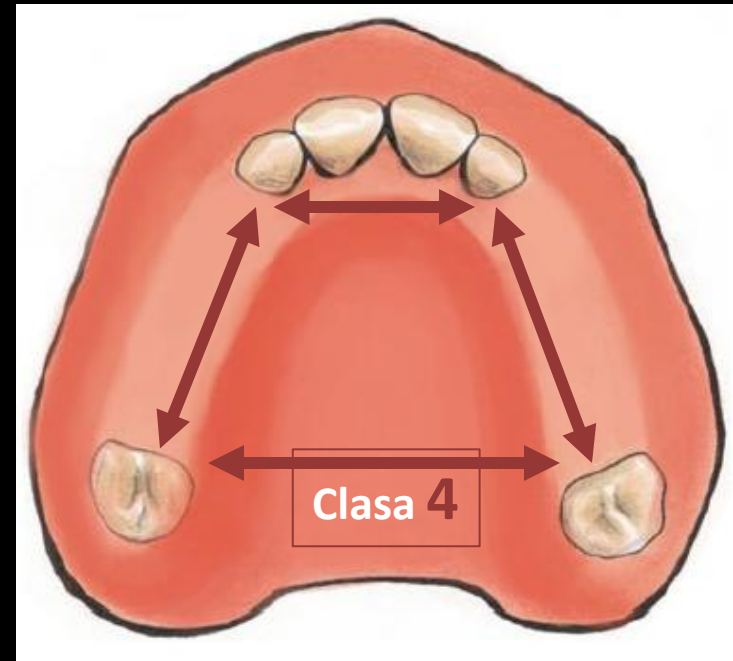
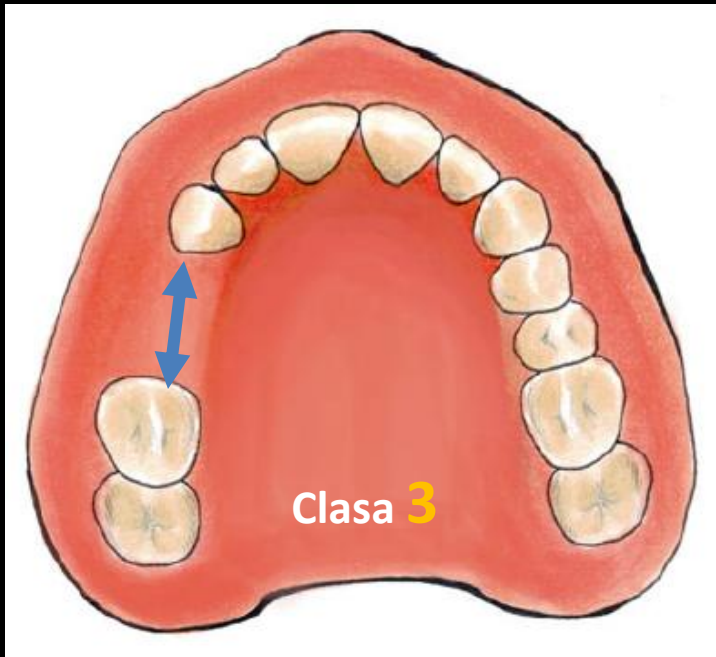


Clasificarea edentațiilor parțiale

CUMMER – criteriul terapeutic dat de **linia ce uneste dintii stalpi**

Clasa **3** → linia crosetelor e **unilaterală**, nu depășește linia mediană

Clasa **4** → linia crosetelor e **bilaterală combinată** cu linia transversală (aspect poligonal);



Clasificarea edentațiilor parțiale

FRIEDMAN – criteriul funcțional (afectării funcțiilor)

- ce funcție **indeplineau** de segmentele dentare absente

Clasa **1** → lipsesc dinți cu rol în incizia alimentelor

Clasa **2** → lipsesc dinți din regiunea laterală cu rol în zdrobire și faramitare;

→ **2.1** - bresa delimitată de dinți restanți anterior și posterior

→ **2.2** - bresa delimitată de dinți restanți doar anterior



Curs 1

Edentația parțială

-considerații generale, clasificări-

Definiție

Forme clinice - dobândită
- inaparentă
- aparentă
- adevărată
- pseudoedentația

Cauze - dobândite
- ereditare

Complicații - locale
- locoregionale
- generale

Clasificare - Kennedy
- Costa
- Cummer
- Friedman